HagaZiekenhuis

Ectropion (een naar buiten gedraaid onderooglid)

Bij een ectropion is de rand van uw onderooglid verslapt. Hierdoor draait deze naar buiten. De rode binnenkant van het ooglid is dan te zien. Vaak is uw oog daarbij geïrriteerd omdat het ooglid minder goed sluit. Door het draaien komt ook het afvoerkanaaltje van het traanvocht een beetje van het oog af. Daardoor kan uw oog gaan tranen.

Oorzaak

Een ectropion wordt meestal veroorzaakt door veroudering van de weefsels van het ooglid, waardoor horizontale verslapping optreedt. De afwijking kan ook veroorzaakt worden door een tekort aan huid als gevolg van huidziekten of littekens, en door zwelling als gevolg van een infectie of een tumor.

Behandeling

Wanneer het ectropion wordt veroorzaakt door verslapping, kan dit verholpen worden door het ooglid strakker te zetten, soms in combinatie met inkorten van de weefsels aan de binnenkant van het ooglid.

De ingreep vindt plaats in dagbehandeling en gebeurt onder plaatselijke verdoving. De duur van de ingreep in ongeveer 30 minuten.

Na de ingreep heeft u meerdere hechtingen: 2 onder de huid, deze lossen vanzelf op en 3 á 4 huidhechtingen. Deze worden na een week op de polikliniek verwijderd.

Bloedverdunnende medicijnen

Bij ooglidcorrecties diende bloedverdunnende medicijnen voor de ingreep gestopt te worden.

- Gebruikt u één van de volgende bloedverdunnende middelen: sintrom, sintrommitis, marcoumar of acenocoumarol?
  Als u hiervoor bij de Trombosedienst onder behandeling bent, moet u het gebruik van deze middelen **in overleg met de Trombosedienst** enkele dagen voor de operatie stoppen en vier dagen na de operatie herstarten.
- Gebruikt u andere bloedverdunnende medicijnen, zoals Ascal, acetylsalicylzuur of aspirine? Dan kunt u het gebruik hiervan het beste tien dagen voor de operatie stoppen. **Overleg dit wel eerst met uw huisarts of behandelend specialist!**
- **Als u niet mag stoppen met uw bloedverdunnende medicijnen,** overleg dit dan zo spoedig mogelijk met uw behandelend oogarts.

Let op dat diverse pijnstillende en ontstekingsremmende medicijnen eveneens een verhoogde kans op bloedingen geven.

Complicaties

Ooglidoperaties zijn niet gevaarlijk. Zoals aan elke operatie is er toch een risico aan verbonden. Een blauw oog komt vaak voor, maar geneest snel. Lelijke littekens en infecties treden zeer zeldzaam op.

- Tijdens de eerste week na de operatie kan er eventueel wat afscheiding uit het oog komen. Dit is ingedroogd wondvocht. Het is niet iets om u zorgen over te maken.
  Eventueel voorzichtig deppen met lauwwarm water is voldoende om de afscheiding te verwijderen. Zorgt u er wel voor dat de hechtingen droog blijven.
- Het ooglid kan de eerste weken wat gevoelig blijven, dit wordt geleidelijk minder.
- Soms ontwikkelt zich een zwelling in de ooghoek als reactie op de hechtmaterialen. Dit geneest meestal spontaan. Neem wel altijd contact op met de assistente.
- Bij een aantal geopereerde patiënten ontstaat er een over-correctie, dit betekent dat het ooglid na de operatie te ver naar buiten gekanteld staat. Meestal geneest dit binnen 6 weken spontaan. Mocht dit niet zo zijn neem dan contact op met de oogarts. Mogelijk volgt er dan een aanvullende operatie.
- Mocht u andere klachten krijgen, bel altijd voor overleg met de polikliniek.

Het is niet altijd mogelijk een perfect resultaat te krijgen; hoe langer de afwijking bestaat, hoe moeilijker de correctie is. Hieronder ziet u hoe de operatie gaat.

Contact

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde. De polikliniek Oogheelkunde is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 52

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

569224022026